

Identificação Paciente: Rex canino SRD 7 anos 20kg fértil

Identificação tutor/responsável: Custódes

Vet. Solicitante/Procedência: Dra Luana Feitosa Univets

Solicitação/Suspeita: Avaliação hepática (morfologia). Enzima elevadas (ALT, AST), hipoalbuminemia, caquexia, anemia e ascite. Pesquisa de neoplasia e avaliação hepática.

Data/Hora exame: 21/11/24



Exame ultrassonográfico realizado com aparelho portátil Ge Versana Active
Transdutores multi-frequenciais micro-convexo 8C-RS (6-10 MHz) e linear 12L-RS (8-13 MHz)

Relatório Ultrassonográfico

Condições/Limitações do exame: Ascite em moderada à aumentada quantidade. Exame realizado em decúbitos laterais.

Fígado: Margens regulares. Topografia de lobos hepáticos habituais. Parênquima homogêneo, sem evidência de lesões expansivas. Ecotextura e ecogenicidade mantida. Arquitetura vascular portal e intra-hepática preservada quanto ao calibre e trajeto.

Vesícula biliar: Parede espessada e ecogênica, conteúdo anecóico intra-luminal. Vias biliares intra e extra-hepáticas não visibilizadas como habitual.

Baço: Dimensões preservadas. Cápsula esplênica fina e regular. Ecotextura em normalidade. Vasos hiliares em normalidade quanto ao calibre e trajeto.

Trato gastrointestinal: Estratificações parietais e proporções entre camadas preservadas, distribuição topográfica habitual. Sem evidência de acúmulo de conteúdo intra-luminal. Peristaltismo preservado. Conteúdo fecal em cólon com padrão ecográfico em normalidade.

Rins: Deslocados em retroperitônio por ascite. Forma habitual. Dimensões preservadas (6,0 cm). Cápsulas regulares. Arquitetura mantida com distinção córtico-medular e proporções preservadas. Ausência de dilatações pielo-caliciais. **Ureteres:** Não visibilizados.

Vesícula urinária: Topografia habitual. Repleção aumentada, parede regular. Conteúdo anecóico em seu interior.

Próstata: Topografia habitual. Forma mantida. Parênquima homogêneo sem evidência de formações cístico-nodulares.

Testículos: Topografia habitual. Simétricos. Formato, contorno e ecotextura em normalidade. Mediastino testicular preservado. Presença de nódulo ecogênico bem delimitado em testículo esquerdo medindo 0,83 cm 0,60 cm.

Pâncreas: Não visibilizado.

Adrenais: Não visibilizadas.

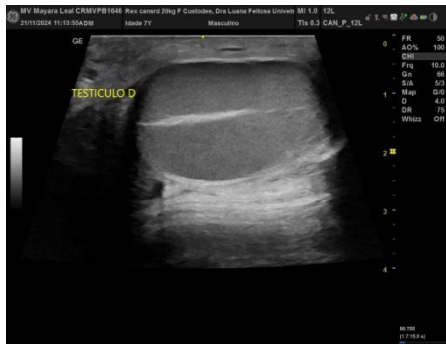
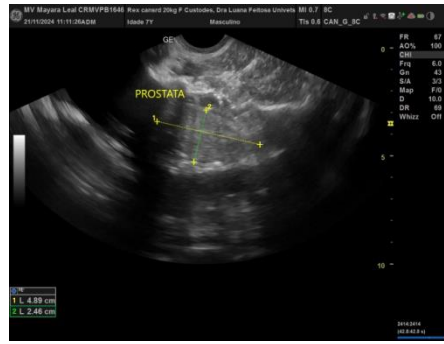
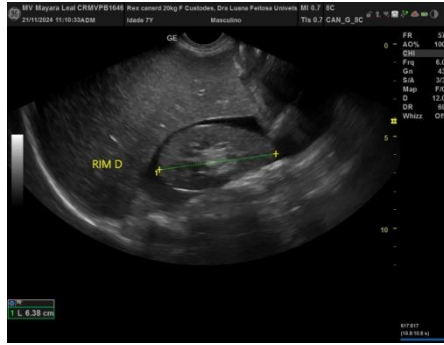
Cavidade peritoneal, retro peritoneal, grandes vasos e linfonodos: Não há evidência sonográfica de linfadenomegalia/linfadenopatia. Sem evidências de alterações nas porções visualizadas de grandes vasos abdominais (aorta e veia cava). Cavidade peritoneal e peritônio íntegros, com preservação da ecogenicidade usual. Presença importante de efusão peritoneal (líquido livre) anecogênico em estudo atual.

Impressão Diagnóstica

Observação: Os achados ultrassonográficos e impressão diagnóstica não devem ser interpretados de forma isolada. Sendo responsabilidade do clínico veterinário solicitante correlacionar as informações obtidas neste exame em associação com o quadro clínico do paciente, conjuntamente com aspectos fisiopatológicos, epidemiológicos e outras técnicas diagnósticas.

- Correlacionando histórico, sinais clínicos e achados laboratoriais sugere ocorrência de ascite (efusão peritoneal) por anemia/hipoalbuminemia resultantes de desequilíbrio na pressão oncótica. Outras causas do desequilíbrio colóidosmótico são: hipoproteinemias por distúrbios hepáticos, nefropatia/síndrome nefrótica, desnutrição, má-absorção, parasitismo intestinal severo.
- Vesícula biliar encontra-se alterada também sinalizando inflamação (colecistite) corroborando com aumento de enzimas de extravasamento hepático em caso clínico. Podendo também achado ter correlação com a hipoalbuminemia.
- Importante associar com demais exames de pesquisa de hematozoários e protozoários (*Leishmania*). E investigação cardíaca: degeneração valva/ICC.
- Nódulo em testículo esquerdo.


Mayara Leal
Médica Veterinária
CRMV-PB 1646




 Mayara Leal
 Médica Veterinária
 CRMV-PB 1646